THAMYRES TOSARELLI

FACETA DIRETA EM RESINA COMPOSTA: INDICAÇÕES, TÉCNICA E LONGEVIDADE

Revisão de literatura

1 INTRODUÇÃO

A aparência do sorriso tem um peso cada vez maior na forma como as pessoas se veem e são vistas. A estética dental passou a ser procurada não só por saúde, mas também por autoestima, aceitação social e bem-estar, e essa procura cresceu bastante com a influência das redes sociais (SOARES; BORGES, 2023). Dentes com alteração de cor, forma ou posição costumam ser percebidos como fora do padrão divulgado pela mídia, o que pode gerar insegurança, timidez e até isolamento, levando o paciente ao consultório em busca de uma solução (ROCHA et al., 2021). Esse impacto não é apenas subjetivo: em um caso relatado por Bento et al. (2021), a qualidade de vida do paciente, medida pelo questionário OHIP-14, melhorou de forma clara após o tratamento estético.

Entre as queixas mais frequentes estão a cor dos dentes, o contorno inadequado e a presença de diastemas. Para resolvê-las, o cirurgião-dentista pode indicar clareamento dental, tratamento ortodôntico, laminados cerâmicos ou facetas diretas em resina composta, e muitas vezes uma combinação dessas opções (SILVA, I. et al., 2021). No caso dos diastemas, por exemplo, as restaurações diretas se destacam pelo tempo reduzido de trabalho, pelo baixo custo e pelo resultado imediato (LIMA et al., 2020).

As facetas são procedimentos que recobrem a face vestibular dos dentes para melhorar sua estética e função, e podem ser confeccionadas de forma direta, com resina composta aplicada no próprio consultório, ou de forma indireta, com peças de cerâmica ou de resina produzidas em laboratório (ALVES; PERES; LIMA, 2022; BRITO; FERREIRA; YAMASHITA, 2022). A técnica direta tem vantagens importantes: exige pouco ou nenhum desgaste do dente, pode ser concluída em uma única sessão, dispensa etapas laboratoriais, tem custo menor e permite reparos

dentro da boca (KORKUT; YANIKOĞLU; GÜNDAY, 2013; SOARES; BORGES, 2023).

Boa parte dessa popularidade se deve à evolução das próprias resinas compostas. Os materiais nano-híbridos e nanoparticulados melhoraram o polimento, a resistência e a estabilidade de cor, permitindo restaurações cada vez mais próximas do dente natural (LANZARETTI et al., 2025; DOMINGUEZ et al., 2024). Em um estudo com pacientes tratados com facetas de resina ou de porcelana, Nalbandian e Millar (2009) não encontraram diferença na melhora estética percebida pelos próprios pacientes entre os dois materiais, o que reforça a resina como uma alternativa válida e mais conservadora.

Por outro lado, a técnica não está livre de problemas. As facetas diretas são mais suscetíveis ao manchamento, ao desgaste e à fratura, e grande parte das falhas está ligada à execução do profissional e a fatores do próprio paciente, como hábitos parafuncionais e higiene deficiente (CRUZ et al., 2023). O sucesso também depende de um bom planejamento, com recursos como o enceramento diagnóstico e o mock-up (REIS et al., 2018), e do respeito aos tecidos periodontais, já que facetas mal adaptadas podem causar inflamação gengival (SANTOS et al., 2022).

Mesmo sendo um tratamento muito difundido, a literatura ainda não chegou a um consenso sobre a durabilidade das facetas diretas quando comparadas às indiretas. Enquanto uma revisão sistemática recente apontou maior sobrevida para as facetas diretas (GALVÃO et al., 2025), outros autores observaram vantagem das facetas indiretas de porcelana (TEIXEIRA et al., 2022). Diante disso, torna-se importante reunir o que os estudos mostram sobre as indicações, a técnica, o planejamento e a longevidade das facetas diretas em resina composta, para que o cirurgião-dentista possa indicá-las com segurança e executá-las com previsibilidade.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Realizar uma revisão de literatura sobre as facetas diretas em resina composta em dentes anteriores, abordando suas indicações, a técnica de confecção, o planejamento e a longevidade clínica.

2.2 Objetivos específicos

a) descrever as indicações, as vantagens e as limitações das facetas diretas em resina composta;
b) discutir como as propriedades das resinas compostas e a forma de polimerização influenciam o desempenho das facetas;
c) apresentar as etapas de planejamento, como o clareamento prévio, o enceramento diagnóstico, o mock-up e as guias de silicone;
d) mostrar a aplicação da técnica em situações clínicas específicas, como dentes escurecidos, fluorose, lesões de cárie inativa e fraturas;
e) relacionar as facetas diretas com a saúde periodontal e com os procedimentos cirúrgicos associados;
f) identificar as principais causas de falha e o impacto do tratamento na satisfação e na qualidade de vida do paciente;
g) comparar a longevidade das facetas diretas com a das facetas indiretas.

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Facetas diretas: conceito, indicações e vantagens

Os trabalhos reunidos nesta seção tratam das facetas diretas de forma mais geral, explicando o que são, quando indicá-las e quais benefícios oferecem em relação a outros tratamentos.

Lima et al. (2020) fizeram uma revisão integrativa sobre o fechamento de diastemas com facetas de resina composta associadas ao clareamento dental. Para os autores, os adesivos e as resinas diretas são uma ótima escolha nesses casos, porque oferecem resultado em menos tempo e permitem manter a estrutura dental sem desgaste, deixando um aspecto natural ao final. Eles também chamaram atenção para a importância de considerar aspectos periodontais e ortodônticos no planejamento e de manter retornos periódicos, o que favorece o resultado estético e funcional a longo prazo.

Silva, I. et al. (2021) revisaram os aspectos gerais das facetas diretas em dentes anteriores e compararam essa técnica a outras opções, como o clareamento, a ortodontia e os laminados cerâmicos. Segundo os autores, as queixas mais comuns dos pacientes envolvem cor, contorno e diastemas. Quando bem executadas, as facetas diretas reproduzem o dente com naturalidade, têm baixo custo, podem ser feitas em sessão única, exigem desgaste mínimo ou nenhum e facilitam o reparo de pequenas falhas. Os autores ressaltaram, porém, que a colaboração do paciente nos cuidados diários é fundamental para que o material dure.

Alves, Peres e Lima (2022) realizaram uma revisão de literatura com o objetivo de discutir as indicações e as técnicas de aplicação das resinas compostas diretas. Os autores explicaram que as facetas podem ser feitas pela técnica direta, com resina composta, ou indireta, geralmente com porcelanas e cerâmicas. Entre as vantagens da técnica direta, destacaram a maior preservação do remanescente dental, a possibilidade de reparo e a capacidade de reproduzir morfologia, cor, translucidez e opacidade. Por outro lado, lembraram que a resistência mecânica dessas restaurações pode ser menor que a das indiretas.

Brito, Ferreira e Yamashita (2022) realizaram uma revisão narrativa sobre as indicações e a longevidade das facetas de resina composta diretas e indiretas, com

trabalhos publicados entre 2001 e 2022 no Google Acadêmico, na SciELO e no Periódicos CAPES. De acordo com os autores, as facetas diretas podem ser indicadas para corrigir alterações de cor e forma, dentes escurecidos ou manchados, amelogênese imperfeita, microdontias, alterações de posição e perdas de estrutura por desgaste. Concluíram que um planejamento correto, somado a uma boa execução e a um acabamento e polimento adequados, é o que garante previsibilidade e durabilidade às facetas.

Soares e Borges (2023) desenvolveram uma revisão integrativa nas bases PubMed, SciELO e Google Acadêmico para apresentar as técnicas, as indicações, os materiais, as vantagens, as desvantagens e a manutenção das facetas em resina composta direta. Os autores descreveram a faceta direta como o recobrimento da face vestibular e a consideraram um procedimento menos invasivo, já que normalmente não exige preparo prévio, a não ser quando o dente precisa de ajustes de anatomia. Destacaram ainda o bom custo-benefício e a possibilidade de concluir o tratamento em uma sessão, desde que o profissional domine a técnica e faça a indicação de forma individualizada.

Dominguez et al. (2024) apresentaram uma revisão ampla sobre as propriedades dos materiais, as técnicas de aplicação e os avanços tecnológicos ligados às facetas de resina composta. Além das vantagens e limitações do tratamento, os autores abordaram o planejamento estético, incluindo análise facial, seleção de cor e mock-up diagnóstico, e discutiram longevidade, manejo de casos complexos e questões éticas e legais. Para eles, as facetas em resina continuam ocupando um papel importante na odontologia estética, por serem uma solução eficaz e confiável para melhorar o sorriso.

Lanzaretti et al. (2025) realizaram uma revisão narrativa nas bases PubMed, Scopus e ScienceDirect sobre a aplicação clínica das facetas diretas, a evolução dos materiais e a satisfação dos pacientes, trazendo também uma explicação prática da técnica. Os autores consideraram as facetas diretas uma alternativa prática, acessível e reversível aos laminados de porcelana, com resultado imediato e pouco preparo do dente. Como pontos negativos, citaram a maior tendência ao manchamento, a menor durabilidade e a necessidade de manutenção, mas observaram que as resinas nano-híbridas e nanoparticuladas trouxeram melhoras no polimento, na resistência e na estabilidade de cor.

3.2 Resinas compostas: propriedades e estabilidade

Como o resultado de uma faceta direta depende muito do material escolhido, esta seção reúne estudos que avaliaram o comportamento das resinas compostas, tanto na boca quanto em laboratório.

Irgang et al. (2020) fizeram uma avaliação clínica retrospectiva de facetas diretas confeccionadas com resinas microparticuladas ou universais (micro-híbridas e nano-híbridas), utilizando os critérios FDI e USPHS. Foram examinadas 74 facetas em 28 pacientes, com média de idade de 42,9 anos, que estavam em uso havia em média três anos, variando de seis meses a dez anos. A taxa de sobrevivência foi de 77%, com 17 falhas no total, sendo três perdas completas, todas no grupo das resinas universais. As resinas microparticuladas tiveram melhor desempenho em brilho, manchamento superficial, correspondência de cor e adaptação marginal, e os dois critérios de avaliação apresentaram resultados semelhantes.

Fernandes et al. (2022) avaliaram em laboratório a microdureza de duas resinas nanoparticuladas submetidas a diferentes técnicas de fotopolimerização. Os autores dividiram 40 corpos de prova em quatro grupos: Filtek Z350 XT e Filtek One Bulk Fill, cada uma polimerizada pela técnica imediata ou pela técnica de pulso tardio. A Filtek Z350 XT apresentou maior dureza que a Filtek One Bulk Fill nas duas técnicas, e a polimerização imediata resultou em valores significativamente maiores. Com isso, concluíram que a técnica convencional alcança maior dureza do que a técnica alternativa de polimerização.

Tozo-Burgos, Escalante-Otárola e Sánchez-Tito (2025) investigaram, também em laboratório, o efeito de uma bebida energética sobre a microdureza e a rugosidade de cinco resinas de alta translucidez: Filtek Z350 XT Translucent, Forma Trans, Palfique LX5, Beautifil II e Opallis T-Neutral. As amostras foram imersas em Red Bull por dez minutos diários durante 30 dias, ficando em saliva artificial entre as imersões. Todas as resinas perderam dureza e ficaram mais rugosas com o tempo. A Filtek Z350 XT manteve a maior dureza, a Forma Trans foi a mais estável e a Beautifil II foi a mais afetada, o que levou os autores a concluir que materiais com nanoaglomerados e zircônia resistem melhor à degradação ácida.

3.3 Planejamento: enceramento, mock-up, guias e clareamento

Os relatos desta seção mostram que, antes de aplicar a resina, o planejamento é a etapa que mais influencia o resultado final, principalmente quando várias facetas são feitas ao mesmo tempo.

Reis et al. (2018) relataram um caso clínico para mostrar a importância do planejamento reverso na reabilitação com facetas diretas. A paciente, de 21 anos, estava insatisfeita com a cor, a forma e o alinhamento dos dentes. Depois do enceramento diagnóstico, os autores fizeram um mock-up com resina bisacrílica (Protemp), que foi ajustado de acordo com as observações da própria paciente. Em seguida, realizaram clareamento de consultório e confeccionaram as facetas, usando a resina IPS Empress Direct para a dentina e a Filtek Z350 para o esmalte. Concluíram que o mock-up motivou a paciente, aumentou a previsibilidade do resultado e deu mais segurança à execução, tanto para o profissional quanto para a paciente.

Pereira et al. (2020) descreveram a reabilitação dos dentes anteriores com facetas em resina composta em um paciente de 23 anos insatisfeito com o sorriso. No exame clínico, foram encontradas restaurações insatisfatórias nas incisais e proximais dos incisivos centrais superiores, além de desarmonia dos dentes 12, 22 e 23 com a face. O tratamento começou com o enceramento diagnóstico em articulador semiajustável e três sessões semanais de clareamento com peróxido de hidrogênio a 35%, aguardando-se 21 dias para a estabilização da cor. Depois disso, as resinas antigas foram removidas e as facetas foram feitas com o auxílio de uma guia de silicone, com incrementos de resina de dentina e de esmalte, seguidos de acabamento e polimento. Os autores concluíram que as facetas em resina são um tratamento viável para alcançar um sorriso harmônico.

Oliveira et al. (2021) relataram o fechamento de diastemas pela técnica direta em uma paciente de 21 anos, com espaços entre os incisivos centrais e laterais superiores. A cor foi escolhida com pequenos incrementos de resina aplicados sobre o dente, e o procedimento foi feito sob isolamento absoluto modificado. A parede palatina foi construída com uma guia de silicone obtida a partir do enceramento diagnóstico, e o acabamento e o polimento foram realizados após sete dias. Para os autores, a técnica direta é uma excelente alternativa para fechar diastemas, desde que se leve em conta a habilidade do operador e a colaboração do paciente, sendo o enceramento e a guia palatina essenciais para a previsibilidade do caso.

Rocha et al. (2021) apresentaram o caso de um paciente incomodado com dentes amarelados, pequenos, separados e levemente desalinhados. Ao exame, havia diastemas, incisivos laterais conoides e caninos levemente girados para distal. O plano de tratamento incluiu clareamento de consultório, enceramento diagnóstico para planejar o caso e confeccionar a guia palatina e, por fim, facetas em resina composta, com uso de resinas de efeito para imitar as características do dente natural. Os autores observaram que o clareamento prévio reduziu a necessidade de desgaste e concluíram que o sucesso depende do conhecimento do profissional, de um planejamento cuidadoso e dos cuidados do paciente, que foi orientado a voltar a cada seis meses para manutenção.

3.4 Facetas diretas em situações clínicas específicas

Além dos casos mais comuns de diastemas e restaurações antigas, a literatura mostra o uso das facetas diretas em situações que exigem cuidados particulares, como dentes muito escurecidos, fluorose e lesões de cárie inativa.

Korkut, Yanıkoğlu e Günday (2013) descreveram a técnica de facetas laminadas diretas em três pacientes com problemas estéticos causados por fraturas, escurecimento e uma restauração antiga deficiente. Um dos casos era de um paciente de 37 anos com fratura das bordas incisais. Os autores citaram como vantagens da técnica direta a ausência de etapa laboratorial, o custo mais baixo, a reversibilidade, a facilidade de polimento e de reparo na boca e a boa adaptação marginal, mas apontaram como desvantagens a menor resistência ao desgaste, o manchamento e as fraturas. Após seis meses de acompanhamento, concluíram que as facetas diretas podem ser uma opção para casos semelhantes.

Bastos et al. (2018) avaliaram o desempenho clínico de facetas diretas feitas com uma resina de carga supra-nano esférica em uma paciente de 39 anos. Os incisivos e caninos superiores apresentavam alteração de cor relacionada ao uso de medicamentos, e a paciente tinha bruxismo. O tratamento incluiu duas sessões de clareamento de consultório com peróxido de hidrogênio a 35%, a remoção das restaurações inadequadas e a confecção das facetas na cor A1 para dentina e esmalte. Seis meses depois, as restaurações estavam com bom aspecto clínico, sem acúmulo de biofilme nem desgaste abrasivo, o que, segundo os autores, sugere um desempenho promissor desses novos compósitos.

Dias et al. (2020) relataram o caso de uma paciente de 21 anos com manchas brancas lisas, brilhantes e bem delimitadas na região cervical dos dentes anteriores superiores, diagnosticadas como lesões de cárie inativa. O tratamento associou o clareamento de consultório às facetas diretas, com enceramento diagnóstico, preparo mínimo, incrementos de resina de dentina e esmalte (Filtek Z350 XT) e polimento com discos, taças e feltros. Os autores destacaram que o diagnóstico correto das manchas e o planejamento adequado foram decisivos para o resultado, que atendeu às expectativas estéticas da paciente.

Falcão et al. (2023) relataram a confecção de uma faceta direta com pigmentos opacificadores em um paciente de 54 anos com escurecimento severo do dente 21. O dente tinha histórico de trauma, já havia passado por tratamento endodôntico e não podia receber um novo clareamento interno. Os autores aplicaram uma mistura fluida de três opacificadores, conferindo o valor da camada por fotografias em preto e branco, e depois fizeram a estratificação com resina translúcida na palatina, resina de dentina opaca e resina acromática translúcida no esmalte. Nas reavaliações de 30 dias e sete meses, a cor continuava estável, e os autores concluíram que a técnica oferece bons resultados em sessão única e com alta previsibilidade.

Joshi (2025) relatou a reabilitação de uma paciente de 43 anos com várias lesões de cárie, o dente 22 escurecido e sem vitalidade, exposição gengival excessiva e assimetria dos dentes e da gengiva. O tratamento foi feito em etapas: enceramento diagnóstico, tratamento endodôntico e clareamento interno do dente 22, aumento de coroa clínica para melhorar a simetria gengival, tratamento das cáries e, por último, facetas diretas em resina composta. Segundo o relato, a abordagem conservadora preservou a estrutura dental, reduziu o risco de falhas futuras e trouxe um resultado estético muito satisfatório.

Vookanti et al. (2026) apresentaram o tratamento de dentes com fluorose moderada por meio de facetas diretas, concluído em uma única consulta. A cor foi definida pela técnica do botão de resina, o preparo foi mínimo e limitado às áreas manchadas, e a restauração foi feita com resina nano-híbrida em camadas policromáticas, seguida de acabamento e polimento com discos. Os autores concluíram que, com a seleção correta do caso e uma execução cuidadosa, as facetas diretas são uma solução previsível, conservadora e de baixo custo para a fluorose.

3.5 Facetas diretas e o periodonto

A relação entre as facetas e a gengiva aparece tanto como um cuidado necessário durante a técnica quanto como parte do próprio tratamento, quando o sorriso também precisa de correção periodontal.

Silva, B. et al. (2021) relataram a transformação do sorriso de uma paciente com grande exposição gengival e restaurações em resina deficientes. Depois de um planejamento digital para definir as proporções ideais dos dentes, foi realizada a gengivoplastia e, noventa dias depois, o clareamento dental e as facetas em resina composta do dente 15 ao 25. Os autores concluíram que a integração entre periodontia e dentística é essencial para um resultado ideal e duradouro, e observaram um grande impacto do tratamento na autoestima e na qualidade de vida da paciente.

Santos et al. (2022) fizeram uma revisão integrativa sobre o impacto das facetas diretas no tecido periodontal, com base em cinco livros e 17 artigos publicados entre 2003 e 2021. Os autores reconheceram as facetas em resina como uma alternativa conservadora, de resultado imediato e baixo custo, mas alertaram que o uso indiscriminado da técnica pode causar danos ao periodonto. Por isso, defenderam que princípios como o espaço biológico sejam respeitados, mantendo-se uma margem gengival mínima de 3 mm, para evitar inflamação e outras sequelas periodontais.

Lima, Amorim e Pereira (2023) relataram o caso de uma paciente com sorriso gengival e dentes curtos, tratada com gengivectomia em bisel interno associada a facetas em resina composta. Os autores explicaram que a gengivectomia remove o excesso de gengiva e aumenta a coroa clínica, enquanto as facetas devolvem forma, cor, opacidade e translucidez aos dentes. Concluíram que a combinação das duas abordagens, com um bom planejamento e respeito aos princípios estéticos, melhorou a forma, o contorno e o tamanho tanto da gengiva quanto dos dentes, mas que isso exige habilidade e experiência do profissional.

3.6 Falhas, substituição e satisfação do paciente

Os estudos a seguir tratam do outro lado do tratamento: o que acontece quando ele dá errado e como um bom resultado pode mudar a vida do paciente.

Bento et al. (2021) relataram o impacto psicossocial de uma reabilitação anterior com resina composta direta em um paciente de 32 anos, que se queixava do “espaço” entre os dentes e da “cor amarelada”. O exame mostrou um diastema entre os dentes 11 e 21, causado pela desproporção no tamanho dos dentes. O tratamento combinou clareamento de consultório e caseiro com facetas diretas nos dentes 13 a 23, planejadas por fotografias, enceramento diagnóstico e mock-up, e feitas com guia de silicone para a face palatina. O questionário OHIP-14, aplicado antes e depois, passou de 24 para 5 pontos, e os autores concluíram que o tratamento melhorou a qualidade de vida do paciente.

Cruz et al. (2021) descreveram a substituição de facetas em resina composta insatisfatórias nos dentes anteriores superiores de um paciente que reclamava da cor das facetas antigas e de sangramento gengival durante a escovação. O tratamento consistiu em clareamento imediato da arcada inferior, remoção das dez facetas existentes e confecção de dez novas facetas, seguindo princípios estéticos e funcionais. Para os autores, evitar que o paciente se frustre e precise refazer o trabalho depende de uma indicação correta, de um bom planejamento, do domínio da técnica, do conhecimento da anatomia dental, do respeito aos tecidos periodontais e da ética profissional.

Cruz et al. (2023) realizaram uma revisão de literatura nas bases PubMed, Lilacs e Google Acadêmico sobre as principais falhas na execução de facetas em resina composta em dentes anteriores. Entre as falhas encontradas, citaram anatomia incorreta, oclusão inadequada, manejo inadequado do material, problemas periodontais e infiltração por má adaptação. Os autores concluíram que a principal causa das falhas é o desempenho do próprio cirurgião-dentista, responsável por escolher a resina e a técnica incremental corretas, mas que também é preciso considerar as características do paciente, como forças oclusais, variações de pH, higiene deficiente e hábitos parafuncionais, que podem levar ao descolamento ou à fratura das facetas.

3.7 Longevidade: facetas diretas e indiretas

Por fim, um ponto ainda discutido na literatura é quanto tempo as facetas diretas duram em comparação com as indiretas, e os estudos desta seção chegam a conclusões diferentes.

Nalbandian e Millar (2009) realizaram um estudo clínico retrospectivo para comparar a opinião dos pacientes sobre a melhora estética obtida com facetas diretas em resina e com facetas indiretas de porcelana. Dos 145 pacientes consultados, 96 responderam ao questionário. Cada um havia recebido dez facetas de resina (Vitalescence) ou dez de porcelana (Fortress) e avaliou cor, forma, tamanho, linha do sorriso e aparência facial antes e depois do tratamento. Não houve diferença estatística na melhora estética entre os dois materiais, e a conservação do dente, o tempo de tratamento e os custos de reparo e de substituição favoreceram a resina. Os autores concluíram que a escolha do material não muda a percepção estética do paciente e que, quando bem informados, os pacientes podem preferir a opção mais conservadora.

Teixeira et al. (2022) fizeram uma revisão narrativa no PubMed comparando a longevidade de facetas diretas e indiretas em dentes anteriores, incluindo apenas estudos clínicos. Segundo os autores, as facetas diretas de resina apresentaram maior instabilidade de cor, mas facilitaram o ajuste de forma e cor durante o tratamento, enquanto as facetas indiretas de porcelana mostraram maior resistência e estabilidade de cor. Concluíram que as facetas indiretas tiveram uma sobrevida relativamente maior que as restaurações diretas.

Vaz, Lopes e Toledo Neta (2022) relataram um caso em que a reabilitação estética foi usada como alternativa ao tratamento ortodôntico em uma paciente de 21 anos com desalinhamento dos dentes anteriores. A paciente optou por facetas de cerâmica reforçada por dissilicato de lítio nos seis dentes anteriores e por resina composta Z350 XT nos pré-molares. Os autores concluíram que a associação de diferentes materiais corrigiu o alinhamento e devolveu estética e função, ressaltando a importância de um planejamento com fotografias digitais, desenho do sorriso e boa comunicação com o paciente.

Galvão et al. (2025) realizaram uma revisão sistemática, registrada no Prospero, para verificar se existe diferença na taxa de sobrevivência entre facetas diretas e indiretas de resina composta em dentes anteriores. A busca nas bases PubMed, Embase e Cochrane, sem restrição de ano ou idioma, encontrou 50 artigos, dos quais cinco estudos clínicos foram incluídos. A maior parte desses estudos mostrou maior sobrevida para as facetas diretas, e as falhas mais comuns nas duas técnicas foram o descolamento e a fratura. Como os estudos eram muito diferentes entre si, não foi possível fazer uma análise quantitativa, mas os autores

concluíram que as facetas diretas em dentes anteriores parecem durar mais que as indiretas.

REFERÊNCIAS

ALVES, D. L.; PERES, S. S. C.; LIMA, C. M. Faceta direta em resina composta: indicação e técnica. **Revista Cathedral**, v. 4, n. 1, p. 109-116, 2022.

BASTOS, N. A. et al. Clinical performance of the composite resin veneers: the minimally invasive approach. **Archives of Health Investigation**, v. 7, n. 9, p. 392-396, 2018. DOI: 10.21270/archi.v7i9.3151.

BENTO, M. J. et al. Impacto psicossocial na reabilitação estética anterior com resina composta direta: relato de caso. **Archives of Health Investigation**, v. 10, n. 2, p. 209-214, 2021. DOI: 10.21270/archi.v10i2.5083.

BRITO, J. A. O.; FERREIRA, V. S.; YAMASHITA, R. K. Indicações e longevidade das facetas de resina composta: revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 13, e467111335738, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i13.35738.

CRUZ, A. I. et al. Troca de facetas em resina composta insatisfatórias, buscando adequação anatômica e estética: relato de caso. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 14, e169101421740, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i14.21740.

CRUZ, K. F. et al. As principais falhas na execução de facetas em resina composta em dentes anteriores: revisão de literatura. **Revista Cathedral**, v. 5, n. 3, p. 75-86, 2023.

DIAS, P. et al. Aesthetic restoration using composite resin in teeth with inactive carious lesions: a conservative and predictable approach. **RGO: Revista Gaúcha de Odontologia**, v. 68, e20200052, 2020. DOI: 10.1590/1981-86372020000522018010l.

DOMINGUEZ, G. P. et al. Facetas diretas em resina composta: uma revisão abrangente. **Research, Society and Development**, v. 13, n. 7, e12213746470, 2024. DOI: 10.33448/rsd-v13i7.46470.

FALCÃO, A. et al. Faceta direta de resina composta utilizando pigmentos opacificadores para reabilitação estética anterior de dente escurecido: relato de caso. **Revista Naval de Odontologia**, v. 50, n. 1, p. 15-20, 2023.

FERNANDES, L. K. P. et al. O método de fotopolimerização é capaz de influenciar nos valores de microdureza das resinas compostas? Um estudo in vitro. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 51, e20220043, 2022. DOI: 10.1590/1807-2577.04322.

GALVÃO, B. W. L. et al. Longevidade clínica das facetas diretas e indiretas em resina composta em dentes anteriores: uma revisão sistemática. **RSBO**, v. 22, n. 2, p. 308-321, 2025.

IRGANG, L. et al. A clinical evaluation of direct veneers made with two types of composites. **Journal of Research in Dentistry**, v. 8, n. 1, p. 10-16, 2020. DOI: 10.19177/jrd.v8e1202010-16.

JOSHI, S. Aesthetic smile makeover with direct resin composite veneers: a case report. **Scientiarum: A Multidisciplinary Journal**, v. 1, n. 5, p. 1-5, 2025. DOI: 10.54646/SAPARS.2025.22.

KORKUT, B.; YANIKOĞLU, F.; GÜNDAY, M. Direct composite laminate veneers: three case reports. **Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects**, v. 7, n. 2, p. 105-111, 2013. DOI: 10.5681/joddd.2013.019.

LANZARETTI, G. et al. Esthetic smile rehabilitation with direct composite veneers: a narrative review with a practical explanation of the technique. **Minerva Dental and Oral Science**, v. 74, n. 4, p. 266-272, 2025. DOI: 10.23736/S2724-6329.25.05161-7.

LIMA, A. P. M.; AMORIM, J. C.; PEREIRA, T. S. Reabilitação estética anterior com gengivectomia e facetas em resina composta. **Scientia Generalis**, v. 4, n. 2, p. 93-103, 2023. DOI: 10.22289/sg.V4N2A7.

LIMA, H. E. R. et al. Fechamento de diastema utilizando resina composta. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 12, p. 95036-95045, 2020. DOI: 10.34117/bjdv6n12-115.

NALBANDIAN, S.; MILLAR, B. J. The effect of veneers on cosmetic improvement. **British Dental Journal**, v. 207, E3, 2009. DOI: 10.1038/sj.bdj.2009.609.

OLIVEIRA, L. M. O. et al. Fechamento de diastema pela técnica direta em resina composta: relato de caso clínico. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 16, e431101624060, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i16.24060.

PEREIRA, M. R. et al. Reabilitação estética com resina composta em paciente jovem: relato de caso clínico. **Revista Odontológica do Brasil Central**, v. 29, n. 88, p. 24-28, 2020.

REIS, G. R. et al. Mock-up: previsibilidade e facilitador das restaurações estéticas em resina composta. **Revista Odontológica do Brasil Central**, v. 27, n. 81, p. 105-111, 2018.

ROCHA, A. O. et al. Intervenção estética anterior por meio de facetas diretas em resina composta: relato de caso. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 3, e6439, 2021. DOI: 10.25248/REAS.e6439.2021.

SANTOS, R. G. et al. O impacto das facetas diretas em resina composta sobre o tecido periodontal: revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 7, e54511730235, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i7.30235.

SILVA, B. J. et al. Transformação de sorriso envolvendo cirurgia plástica periodontal e facetas em resina composta: relato de caso. **Revista Odontológica Integrativa do Centro-Oeste**, v. 1, n. 1, p. 75-86, 2021.

SILVA, I. B. et al. Facetas diretas em resina composta: uma abordagem conservadora (revisão da literatura). **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 11, p. 109291-109307, 2021. DOI: 10.34117/bjdv7n11-518.

SOARES, I. S.; BORGES, T. S. Técnicas e indicações para a realização das facetas em resina composta direta: uma revisão integrativa da literatura. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 6, e3312641962, 2023. DOI: 10.33448/rsd-v12i6.41962.

TEIXEIRA, B. C. et al. Longevidade de tratamento reabilitador com facetas diretas e indiretas em dentes anteriores: uma revisão narrativa. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 15, e409111537369, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i15.37369.

TOZO-BURGOS, J. G.; ESCALANTE-OTÁROLA, W.; SÁNCHEZ-TITO, M. Erosive resistance of high-translucency resin composites: new insights for esthetic dentistry. **Journal of Clinical and Experimental Dentistry**, v. 17, n. 12, p. e1508-e1516, 2025. DOI: 10.4317/jced.63433.

VAZ, M. M.; LOPES, G. F.; TOLEDO NETA, M. E. Tratamento reabilitador estético como uma possibilidade para pequenas correções de alinhamento. **Revista Odontológica Integrativa do Centro-Oeste**, v. 2, n. 1, p. 28-42, 2022.

VOOKANTI, V. R. R. et al. Aesthetic transformation of fluorosed teeth using minimally invasive direct composite veneers: a case report. **University Journal of Dental Sciences**, v. 12, n. 1, p. 91-96, 2026. DOI: 10.21276/ujds.2026.12.1.17.